EXCMO. AYUNTAMIENTO DE UTRERA | SUBESCALA TÉCNICA - GRUPO A2

Educador/a Social | BOP Sevilla nº 102 (29/05/2026) | Tema 55 - Específico

Tema 55: Estimulación temprana. Funciones de la estimulación temprana. Áreas de intervención en la estimulación. Elaboración de los programas de estimulación temprana

Convocatoria: Técnico/a Medio de Educación Social (Subescala Técnica, Grupo A2) — Excmo. Ayuntamiento de Utrera (Sevilla) **Oferta de Empleo Público:** Consolidada (BOP de Sevilla nº 102, de 29/05/2026) **Bloque:** Materias Específicas (Tema 55)

1. Introducción y Justificación Epistemológica y Legal

Los primeros años de la vida humana constituyen la etapa de mayor vulnerabilidad, pero también de máxima oportunidad para el desarrollo del potencial biopsicosocial del individuo. Lejos de concebirse como una fase de maduración meramente pasiva, las neurociencias, la psicología evolutiva y la Pedagogía Social han evidenciado que la interacción temprana entre la dotación biológica del lactante y la calidad de los estímulos afectivos, cognitivos, sensoriales y lingüísticos provistos por el ambiente modela de forma irreversible la arquitectura cerebral del ser humano.

Históricamente conocida bajo la denominación de "estimulación precoz", la disciplina ha experimentado una profunda evolución paradigmática: ha transitado desde un enfoque médico-rehabilitador, centrado de manera casi exclusiva en el déficit del menor en sesiones clínicas artificiales, hacia el modelo integral y biopsicosocial de la **Atención Temprana**, formalizado canónicamente en el **Libro Blanco de la Atención Temprana** (**Grupo de Atención Temprana - GAT, 2000**) y consagrado legislativamente en la comunidad autónoma mediante la histórica **Ley 1/2023, de 16 de febrero, de Atención Temprana de Andalucía.**

En el ámbito competencial de la Administración Local, y específicamente en el **Excmo. Ayuntamiento de Utrera**, el/la Técnico/a Medio de Educación Social (Subescala Técnica, Grupo A2) desempeña un rol preventivo, comunitario y sociofamiliar de primer orden. Desde el **Centro de Servicios Sociales Comunitarios (calle Catalina de Perea, 32)**, en estrecha colaboración con el **Centro de Atención Infantil Temprana (CAIT) de Utrera**, con la red de **Escuelas Infantiles (0 a 3 años)**, con los programas de la estrategia **ERACIS+ en la Barriada El Tinte** y con los dispositivos descentralizados en las pedanías de **Guadalema de los Quintero, Trajano y Pinzón**, el/la Educador/a Social interviene de forma directa en la detección precoz de situaciones de **riesgo psico-socio-ambiental**, en el empoderamiento de familias vulnerables para enriquecer los entornos de crianza y en la articulación de respuestas inclusivas en el medio natural.

Marco Legal y Normativo Fundamental

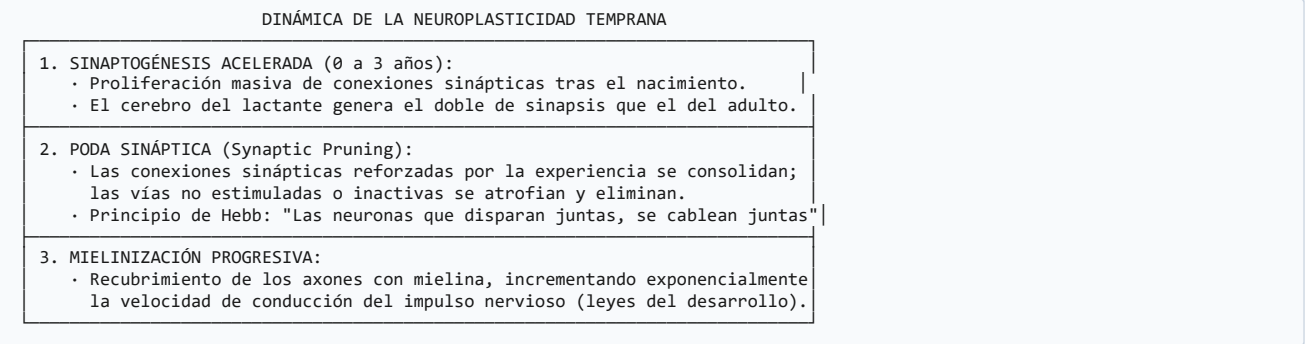
- **Constitución Española de 1978**: El **artículo 27 de la CE** consagra el derecho fundamental a la educación; el **artículo 39 de la CE** encomienda a los poderes públicos la protección social, económica y jurídica de la familia y de los menores; y el **artículo 49 de la CE** (reformulado en su redacción histórica de 2024) consagra el mandato a los poderes públicos de impulsar políticas que garanticen la autonomía personal, la inclusión social y la atención integral de las personas con discapacidad en entornos accesibles y con enfoque de derechos humanos.
- **Ley Orgánica 2/2006 (LOE), modificada por la LOMLOE 3/2020**: Sus artículos 12 a 15 regulan la **Educación Infantil (0-3 y 3-6 años)** como una etapa educativa única con identidad propia y carácter voluntario, enfatizando la detección precoz y la atención temprana a las necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE).
- **Ley 1/2023, de 16 de febrero, de Atención Temprana de Andalucía**: Norma de vanguardia que eleva la atención temprana a la categoría de **derecho subjetivo universal y gratuito** para toda la población infantil de 0 a 6 años residente en Andalucía, regulando las **Unidades de Atención Infantil Temprana (UAIT)** en el sistema sanitario y la red de **Centros de Atención Infantil Temprana (CAIT).**
- **Ley 4/2021, de 27 de julio, de Infancia y Adolescencia de Andalucía**, y **Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía.**

- **Decreto 100/2022, de 7 de junio**, que regula el papel de los Equipos de Tratamiento Familiar (ETF) y la protección ante situaciones de riesgo o desprotección moderada en la primera infancia.

2. Fundamentos Neurobiológicos y del Desarrollo Humano

2.1. Plasticidad Cerebral y Sinaptogénesis

El fundamento neurobiológico incontestable de la estimulación temprana descansa en el fenómeno de la **plasticidad cerebral o neuroplasticidad**: la extraordinaria capacidad que posee el sistema nervioso central en las primeras etapas de la vida para modificar su estructura anatómica y su organización funcional como respuesta directa a los estímulos del medio ambiente, al aprendizaje y a las experiencias vividas (**Kandel, Schwartz y Jessell, 2012**).



Durante los tres primeros años de vida se produce un ritmo de desarrollo cerebral irrepetible en cualquier otra fase del ciclo vital. Sin embargo, este proceso está regido por el principio epigenético: los genes establecen el mapa o plano general del desarrollo neural, pero son **las experiencias relacionales y ambientales las que determinan qué circuitos se consolidan y cuáles desaparecen.**

2.2. Periodos Críticos vs. Periodos Sensibles

La neurobiología evolutiva distingue dos conceptos cronológicos esenciales:

- **Periodo Crítico**: Ventana temporal biológica estricta e inflexible durante la cual un determinado circuito neuronal requiere necesariamente recibir estímulos ambientales específicos para consolidar una función básica; si el estímulo no se produce en dicho lapso, la función jamás podrá adquirirse con normalidad (ej., desarrollo de la corteza visual binocular demostrado por **Hubel y Wiesel, 1970**).
- **Periodo Sensible**: Franja temporal más amplia, maleable y flexible en la que el cerebro es extraordinariamente receptivo y permeable a ciertos aprendizajes complejos (como la adquisición del lenguaje natural o la formación de los vínculos primarios de apego), siendo el aprendizaje mucho más fluido y eficaz que en etapas adultas, aunque no imposible fuera de él (**Eric Lenneberg, 1967**).

2.3. Deprivación Afectiva, Estrés Tóxico y Ambiente Enriquecido

La ausencia de estimulación o la vivencia de adversidades tempranas produce alteraciones neuroanatómicas demostradas:

- **Estudios de René Spitz (1945) sobre Hospitalismo y Depresión Anaclítica**: Demostraron empíricamente que lactantes institucionalizados que recibían cuidados médicos y nutricionales higiénicos impecables, pero carecían de estimulación afectiva, contacto físico y mirada cálida, sufrían un severo retraso psicomotor, apatía, atrofia del sistema inmunológico e incluso la muerte.
- **Experimentos de Harry Harlow (1958)** con crías de macaco rhesus: Demostraron la primacía de la necesidad biológica de apego, calidez y contacto corporal ("confort del contacto") sobre la mera provisión de alimento.
- **Estrés Tóxico en la Infancia (Shonkoff et al., 2012)**: La exposición prolongada a negligencia, violencia intrafamiliar o pobreza extrema sin el amortiguador de un adulto protector hiperactiva el eje hipotálamo-hipofisario-adrenal (HHA), liberando niveles lesivos de cortisol que dañan la microestructura del hipocampo (memoria) y de la corteza prefrontal (autorregulación).

3. Funciones de la Estimulación Temprana

El **Libro Blanco de la Atención Temprana (GAT, 2000)** y la **Ley 1/2023 de Andalucía** estructuran las funciones de la estimulación e intervención temprana en tres niveles preventivos universales, en consonancia con la Organización Mundial de la Salud (OMS):

```
                    NIVELES DE PREVENCIÓN EN ATENCIÓN TEMPRANA
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ PREVENCIÓN PRIMARIA (Universal - Población General):                 │
│ · Promoción de la salud materno-infantil, planificación familiar.   │
│ · Fomento de la parentalidad positiva y apego seguro en el medio comunitario.
│ · Erradicación de tóxicos en el embarazo (Síndrome Alcohólico Fetal).│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ PREVENCIÓN SECUNDARIA (Detección Precoz en Poblaciones de Riesgo):  │
│ · Cribados neonatales y pediátricos de desarrollo (Haizea-Llevant, Denver).
│ · Identificación de Riesgo Biológico (prematuridad, anoxia neonatal).
│ · Identificación de Riesgo Psico-Socio-Ambiental (negligencia, exclusión).
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ PREVENCIÓN TERCIARIA (Intervención Especializada ante Trastorno Instaurado):
│ · Tratamiento interdisciplinar directo al menor, a la familia y al entorno.
│ · Minimización de secuelas, optimización de potenciales y adaptación escolar
│ · Prevención de desajustes secundarios y empoderamiento familiar en el CAIT.
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

3.1. Tipología de Población Destinataria según Factores de Riesgo

La estimulación temprana atiende a tres colectivos diferenciados de niños y niñas de 0 a 6 años:

1. Menores con Trastorno del Desarrollo Confirmado: Aquellos que presentan una alteración diagnosticada de carácter transitorio o permanente en su desarrollo motor, sensorial, cognitivo, comunicativo o socioafectivo (parálisis cerebral, síndrome de Down, espina bífida, sordoceguera, trastorno del espectro autista - TEA).

2. Menores con Riesgo Biológico: Niños y niñas que durante el periodo pre, peri o posnatal han estado sometidos a situaciones que incrementan la probabilidad de presentar alteraciones en el neurodesarrollo: gran prematuridad (edad gestacional inferior a 32 semanas), muy bajo peso al nacer (<1.500 gramos), anoxia o asfixia perinatal, convulsiones neonatales o infecciones del sistema nervioso central (meningitis).

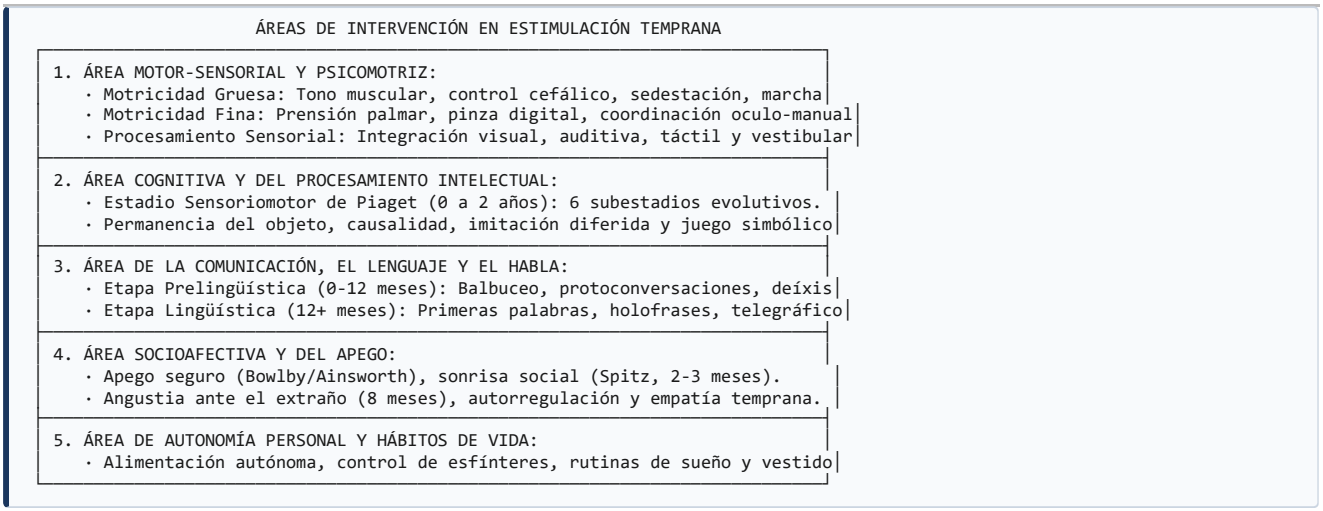
3. Menores con Riesgo Psico-Socio-Ambiental: Lactantes que viven en condiciones sociales, familiares o culturales desfavorables que amenazan su adecuado desarrollo evolutivo: extrema pobreza y privación material, progenitores con drogodependencias o trastornos mentales graves no compensados, negligencia en cuidados básicos, violencia vicaria o dinámicas de desestructuración familiar. **Este colectivo constituye el foco predilecto de intervención del/de la Educador/a Social en los Servicios Sociales de Utrera.**

3.2. Funciones Complementarias de la Estimulación Temprana

- **Función Facilitadora y de Andamiaje**: Provisión de experiencias y mediaciones estructuradas (**Vygotsky, Bruner**) que permiten al menor alcanzar hitos evolutivos que no lograría de manera espontánea.
- **Función de Empoderamiento y Soporte Familiar**: Acompañar el impacto emocional tras el diagnóstico, transformar la culpa en competencia parental y capacitar a madres y padres para que conviertan las rutinas diarias del hogar en oportunidades continuas de estimulación natural (**Robin McWilliam, 2010**).
- **Función de Inclusión y Coordinación Ecológica**: Articulación de redes entre salud, educación y servicios sociales, asesorando a las Escuelas Infantiles en las adaptaciones de acceso al currículo.

4. Áreas de Intervención en la Estimulación Temprana

El desarrollo infantil es un proceso holístico, unitario e interdependiente. Sin embargo, para su evaluación metodológica y programación técnica, se estructura en **cinco áreas funcionales interconectadas**:



4.1. Área Motor-Sensorial y Psicomotriz

1. Leyes del Desarrollo Psicomotor:

- **Ley Céfalo-Caudal:** El control y la maduración muscular progresan desde la cabeza hacia los pies (el menor controla primero el cuello y la cabeza, luego el tronco, y finalmente las extremidades inferiores para caminar).
- **Ley Próximo-Distal:** El control muscular progresa desde el eje central del cuerpo hacia las extremidades periféricas (controla antes los hombros y brazos que los dedos de las manos).

2. Hitos de la Motricidad Gruesa:

- *0-3 meses*: Sostén cefálico estable en decúbito prono.
- *6 meses*: Sedestación con apoyo (trípode) y volteo intencional.
- *8-9 meses*: Sedestación autónoma estable y gateo coordinado.
- *10-12 meses*: Bipedestación con apoyos y marcha guiada.
- *12-15 meses*: Marcha autónoma independiente.

3. Motricidad Fina y Manipulación:

- Evolución desde el reflejo involuntario de prensión palmar (*grasping reflex*) hacia la prensión voluntaria en pinza inferior (9 meses) y **pinza digital superior o fina** (índice-pulgar a los 12 meses), permitiendo la manipulación de objetos y el uso de instrumentos.

4. Integración Sensorial (Jean Ayres, 1979):

- Estimulación y modulación del sistema táctil, vestibular (equilibrio y movimiento) y propioceptivo (conciencia corporal).

4.2. Área Cognitiva: El Periodo Sensoriomotor de Jean Piaget (0 a 2 Años)

Jean Piaget (1936) demostró que la inteligencia en los dos primeros años de vida no es conceptual ni abstracta, sino puramente práctica, sensoriomotora y ligada a la acción inmediata. Se estructura en **seis subestadios canónicos:**

1. *Subestadio 1 (0-1 mes): Ejercicio de los reflejos innatos* (succión, prensión).

2. *Subestadio 2 (1-4 meses): Reacciones circulares primarias* (repetición de conductas casuales placenteras centradas en el propio cuerpo: chuparse el pulgar).

3. *Subestadio 3 (4-8 meses): Reacciones circulares secundarias* (repetición de acciones dirigidas al exterior para mantener espectáculos interesantes: sacudir un sonajero).

> **4.** *Subestadio 4 (8-12 meses): Coordinación de esquemas secundarios* (conducta intencional orientada a metas; apartar un cojín para coger un juguete oculto; inicio de la **permanencia del objeto**).

5. *Subestadio 5 (12-18 meses): Reacciones circulares terciarias* (experimentación activa y variación sistemática de conductas para ver qué sucede: ensayo y error, tirar objetos desde diferentes alturas).

6. *Subestadio 6 (18-24 meses): Invención de nuevos medios mediante combinaciones mentales* (tránsito a la representación simbólica; comprensión súbita o *insight*; inicio de la permanencia del objeto total y de la imitación

diferida).

4.3. Área de la Comunicación y el Lenguaje

- **Etapa Prelingüística (0 a 12 meses)**:
- *0-2 meses*: Llanto diferenciado (hambre, dolor, sueño) y vocalizaciones reflejas.
- *3-6 meses*: Balbuceo inicial y arrullos (*cooing*); aparición de las **protoconversaciones** (turnos de intercambio de miradas y sonidos entre la madre y el bebé).
- *8-10 meses*: Balbuceo canónico repetitivo ("ba-ba", "ma-ma") y desarrollo de la **atención conjunta (*joint attention*) (Jerome Bruner, 1983)**. Gestos protoimperativos (señalar para pedir un objeto) y protodeclarativos (señalar para compartir la atención y el interés con el adulto).
- **Etapa Lingüística (a partir de los 12 meses)**:
- *12-18 meses*: Primeras palabras con valor de frase completa (**holofrases**; ej., "agua" para expresar "quiero agua").
- *18-24 meses*: **Habla telegráfica** y combinación de dos palabras ("papá ven", "nene pan"); explosión léxica (aumento de 50 a más de 200 palabras).

4.4. Área Socioafectiva y del Vínculo de Apego

- La estimulación temprana se cimenta en la **Teoría del Apego de John Bowlby y Mary Ainsworth**:
- Aparición de la **sonrisa social (2-3 meses)** descrita por **René Spitz** como primer organizador psíquico.
- Aparición de la **angustia de separación y miedo a los extraños (8 meses)** (segundo organizador psíquico de Spitz), que confirma que el menor ha discriminado la figura principal de apego.
- La presencia de un **apego seguro** proporciona la base segura (*secure base*) desde la cual el niño se aventura a explorar el entorno físico y cognitivo.

4.5. Área de Autonomía Personal y Hábitos de Vida Diaria

- Adquisición de pautas de autorregulación biológica y autocuidado: transición de la lactancia a la cuchara y sólidos; adquisición del control de esfínteres (alcanzado de forma madurativa general entre los 24 y 36 meses); lavado de manos; colaboración en el vestido; respeto de rutinas de descanso nocturno estructurado.

---

5. Elaboración de los Programas de Estimulación Temprana

El diseño e implantación de un programa de estimulación temprana debe alejarse de la mera repetición mecánica de ejercicios y articularse conforme a un **proceso metodológico sistemático en cuatro fases interconectadas**:

```
                FASES METODOLÓGICAS DE UN PROGRAMA DE ESTIMULACIÓN
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ FASE 1: DETECCIÓN, DERIVACIÓN Y EVALUACIÓN INTERDISCIPLINAR:         │
│ · Cribado en Pediatría / Escuela Infantil / Servicios Sociales.      │
│ · Derivación a la Unidad de Atención Infantil Temprana (UAIT - Ley 1/2023).│
│ · Evaluación global con escalas estandarizadas (Bayley, Brunet-Lézine).│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ FASE 2: DISEÑO DEL PLAN INDIVIDUALIZADO DE INTERVENCIÓN (PII):       │
│ · Formulación de metas operativas jerarquizadas y centradas en la familia.│
│ · Selección de estrategias basadas en rutinas naturales (Robin McWilliam).│
│ · Planificación de sesiones y adaptación del entorno (juego, materiales).│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ FASE 3: EJECUCIÓN Y MEDIACIÓN SOCIOEDUCATIVA:                        │
│ · El juego como principio pedagógico vertebrador indispensable.      │
│ · Coaching y modelado parental: empoderamiento de la familia en el hogar.│
│ · Coordinación regular con la Escuela Infantil (0-3 años).           │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ FASE 4: EVALUACIÓN CONTINUA, SEGUIMIENTO Y TRANSICIÓN:               │
│ · Evaluación trimestral de progresos y reajuste del PII.             │
│ · Protocolo de Transición a la Escuela a los 3 o 6 años con el EOE.  │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

5.1. Fase 1: Detección, Derivación y Evaluación Interdisciplinar

1. Instrumentos de Cribado y Detección Temprana:

- **Escala Haizea-Llevant (0 a 5 años)**: Instrumento de cribado canónico en atención primaria de salud en España, que evalúa desarrollo postural, manipulativo, comunicativo y socialización mediante una gráfica de percentiles de adquisición.
- **Test de Denver (DDST)**: Evalúa motricidad gruesa, fina, lenguaje y área personal-social.

2. Escalas Diagnósticas de Desarrollo Infantil:

- **Escalas Bayley de Desarrollo Infantil (BSID-III)**: Patrón de referencia internacional; evalúa escalas cognitiva, motora, del lenguaje, socioemocional y conducta adaptativa de 1 a 42 meses.
- **Escala de Brunet-Lézine Revisada (BLR)**: Evalúa control postural, coordinación oculo-motriz, lenguaje y sociabilidad (0 a 30 meses).
- **Inventario de Desarrollo Battelle**: Evalúa 5 áreas y proporciona cociente de desarrollo (0 a 8 años).

5.2. Fase 2: Diseño del Plan Individualizado de Intervención (PII)

- Conforme a la **Ley 1/2023 de Andalucía**, la intervención se formaliza a través del **Plan Individualizado de Intervención (PII)** emitido por el CAIT:
- **Metas centradas en la familia**: Superación del modelo técnico centrado en el terapeuta. Se aplica el **Modelo Basado en Rutinas de Robin McWilliam (2010)**: los objetivos no se redactan como ejercicios de mesa (*"hacer torres de 4 cubos"*), sino incardinados en las rutinas reales de la familia (*"que el niño coopere en la hora del baño emitiendo sonidos y sosteniendo la esponja"*).
- **Materiales y Entornos Estimulantes**:
- **Cesta de los Tesoros (Elinor Goldschmied, 6 a 12 meses)**: Cesto con objetos cotidianos de materiales naturales (madera, metal, tela, cuero; nunca plástico), para estimular los cinco sentidos y la exploración heurística libre.
- **Juego Heurístico (12 a 24 meses)**: Exploración combinatoria y clasificación de objetos diversos en bolsas de tela.
- **Salas de Estimulación Multisensorial (Snoezelen)**: Entornos inmersivos controlados con fibra óptica, tubos de burbujas, música y aromaterapia para modular estados emocionales y sensoriales.

5.3. Fase 3: Ejecución y Principios Metodológicos Fundamentales

- **El Juego como Motor Absoluto**: El juego no es una recompensa ni una pausa; es la actividad vital a través de la cual el niño explora el mundo, ensaya roles, elabora angustias y construye esquemas cognitivos.
- **Respeto a los Ritmos y Necesidades Biológicas**: Jamás sobrestimular ni forzar respuestas en estados de fatiga o irritación; evitar la saturación sensorial.
- **Intervención en el Medio Natural**: Las sesiones de estimulación deben trasladarse preferentemente al hogar, a la guardería y a los parques, empoderando a las familias mediante modelado directo.

5.4. Fase 4: Evaluación y Protocolo de Transición Escolar

- La evaluación debe ser procesual, continua y formativa.
- A los 3 años (incorporación al 2º ciclo de Educación Infantil en CEIP) o a los 6 años (tránsito a Primaria), se activa el **Protocolo de Transición Intersectorial de Andalucía**: reunión técnica obligatoria entre el CAIT, los Servicios Sociales Comunitarios y el **Equipo de Orientación Educativa (EOE)** especializado de la Consejería de Desarrollo Educativo, garantizando el traspaso del informe psicopedagógico y la asignación inmediata de recursos de apoyo (PT, AL, monitor escolar).

6. El/La Educador/a Social en la Atención Temprana Municipal

En la Administración Local, el/la Educador/a Social no compite ni invade las funciones de los terapeutas clínicos del CAIT (fisioterapeutas, logopedas o psicólogos sanitarios). Su identidad profesional y su aportación nuclear residen en la **dimensión socioeducativa, comunitaria y familiar en el medio natural**:

- **Detección y Captación Activa del Riesgo Socioambiental**: Identificar precozmente en barrios desfavorecidos o en infraviviendas situaciones de deprivación sensorial y afectiva grave antes de que se produzca una lesión en el neurodesarrollo.
- **Coaching Parental y Modelado en el Hogar**: Acudir al domicilio familiar para enseñar a madres y padres jóvenes o con escasas habilidades a hablar a sus hijos, sostener la mirada, jugar en el suelo, eliminar el uso de pantallas digitales antes de los 3 años y establecer rutinas estables de sueño y alimentación.
- **Acompañamiento a Recursos Especializados**: Derivar y acompañar físicamente a familias reticentes, desestructuradas o pertenecientes a minorías étnicas hasta el CAIT de Utrera, derribando prejuicios y desconfianzas institucionales.

- **Dinamización de Grupos de Crianza Positiva:** Coordinar talleres grupales para familias con bebés en centros cívicos o de servicios sociales.

7. Enfoque Práctico en los Servicios Sociales del Excmo. Ayuntamiento de Utrera

7.1. Estructura y Dependencias Centrales

El **Excmo. Ayuntamiento de Utrera** centraliza su dispositivo socioeducativo en el **Centro de Servicios Sociales Comunitarios (CSSC)**, situado en la **calle Catalina de Perea, nº 32**. Desde estas dependencias se articula la coordinación interinstitucional con la red de atención temprana:

- **Coordinación con el Centro de Atención Infantil Temprana (CAIT) de Utrera:** Reuniones técnicas bimensuales para el seguimiento conjunto de menores empadronados en Utrera con riesgo socioambiental derivado del CSSC o con PII en ejecución.
- **Coordinación con el Equipo de Tratamiento Familiar (ETF):** Aplicación del instrumento **VALÓRAME** (**Decreto 100/2022**) cuando el retraso del desarrollo en lactantes se asocia a negligencia o desprotección moderada en el núcleo convivencial.

7.2. Intervención en Zonas Desfavorecidas: ERACIS+ en la Barriada El Tinte

En la **Barriada El Tinte**, clasificada como zona prioritaria de transformación social de Utrera:

- **Espacio Socioeducativo de Primera Infancia (0 a 3 años):** Dinamizado en el Centro Cívico de El Tinte por el/la Educador/a Social en el marco de la estrategia **ERACIS+**:
- Talleres de estimulación sensorial mediante cestas de tesoros y juegos heurísticos.
- Formación a madres jóvenes de **minoría étnica gitana** en pautas de estimulación temprana del lenguaje oral, desmitificando el uso del teléfono móvil o la televisión como "chupete digital" para calmar a los bebés.
- Vinculación obligatoria de los lactantes a las revisiones del Programa de Salud Infantil y Vacunaciones del Centro de Salud Utrera-Sur.

7.3. Coordinación con la Red de Escuelas Infantiles de Utrera

El Educador/a Social actúa como nexo de detección temprana y enlace familiar con los centros de primer ciclo de infantil (0-3 años) del municipio:

- **Escuelas Infantiles (0-3 años) de Utrera:** EI La Muela, EI Los Remedios, EI Baleares, EI El Olivo, entre otras.
- Establecimiento de canales de comunicación directos para la derivación inmediata a la UAIT de lactantes que muestren señales tempranas de autismo (ausencia de sonrisa social, no contacto ocular a los 6 meses, falta de respuesta al nombre o ausencia de señalamiento deíctico a los 12 meses).

7.4. Descentralización en las Pedanías: Guadalema, Trajano y Pinzón

La dispersión rural de Utrera exige una atención itinerante:

- Visitas domiciliarias quincenales del Educador/a Social a las pedanías de **Guadalema de los Quintero, Trajano y Pinzón.**
- Asesoramiento y entrega de kits de materiales de estimulación temprana (juegos de madera, libros de texturas) a familias en situación de aislamiento territorial, garantizando que los menores con dificultades reciban las mismas oportunidades de estimulación y acceso al CAIT de Utrera sin discriminación por residencia.

8. Secciones Pedagógicas de Cierre

A. 25 Datos de Examen (Memorización Directa para Tribunal)

1. Libro Blanco de la Atención Temprana (GAT, 2000): Documento fundacional canónico en España; define la atención temprana de 0 a 6 años, centrada en el niño, la familia y el entorno.

2. Ley 1/2023, de 16 de febrero, de Atención Temprana de Andalucía: Regula la atención temprana en Andalucía como **derecho subjetivo universal y gratuito**; crea los CAIT y las UAIT.

3. Población diana de la Atención Temprana: Niños y niñas de **0 a 6 años** con trastornos en el desarrollo o con riesgo de padecerlos.

4. Tres grupos de población atendida: 1) Con trastorno confirmado, 2) Con riesgo biológico (prematuridad, bajo peso), y 3) Con riesgo psico-socio-ambiental (negligencia, exclusión).

5. Plasticidad cerebral: Capacidad del sistema nervioso para reorganizar su estructura y función en respuesta a estímulos y experiencias ambientales.

6. Periodo Crítico vs. Periodo Sensible: El periodo crítico es una ventana estricta e irreversible (Hubel y Wiesel); el sensible es flexible y permeable al aprendizaje óptimo (Lenneberg).

7. René Spitz (1945): Estudios sobre **hospitalismo** y **depresión anaclítica**; demostró la atrofia y mortalidad infantil producida por la deprivación afectiva.

8. Harry Harlow (1958): Experimentos con macacos rhesus; primacía biológica del afecto y "confort del contacto" sobre el alimento.

9. Tres niveles preventivos (OMS y Libro Blanco): Primaria (universal y comunitaria), Secundaria (detección precoz en poblaciones de riesgo) y Terciaria (intervención directa sobre el trastorno).

10. Jean Piaget (1936): Periodo **Sensoriomotor (0 a 2 años)**; dividido en **seis subestadios**; adquisición de la **permanencia del objeto**.

11. Subestadio 4 de Piaget (8-12 meses): Coordinación de esquemas secundarios; aparición de la conducta intencional y búsqueda de objetos ocultos.

12. Leyes del desarrollo psicomotor: **Ley Céfalo-Caudal** (de la cabeza a los pies) y **Ley Próximo-Distal** (del centro del cuerpo hacia la periferia).

13. Pinza digital superior (fina): Hito manipulativo que se adquiere en torno a los **12 meses** de edad (oposición índice-pulgar).

14. Jerome Bruner (1983): Concepto de **atención conjunta (*joint attention*)** y protoconversaciones tempranas como base de la adquisición lingüística.

15. Holofrase: Palabra única utilizada en la etapa lingüística temprana (12 a 18 meses) con el significado y valor sintáctico de una frase completa.

16. Organizadores psíquicos de René Spitz: Sonrisa social (2-3 meses, 1er organizador); Angustia de separación y miedo a extraños (8 meses, 2º organizador).

17. Escala Haizea-Llevant (0 a 5 años): Instrumento español canónico de cribado rápido en atención primaria de salud.

18. Escalas Bayley (BSID-III): Escala diagnóstica de desarrollo infantil de 1 a 42 meses considerada el patrón de referencia internacional.

19. Robin McWilliam (2010): Modelo de **Intervención Basada en Rutinas** en el entorno natural, frente al modelo clínico tradicional de mesa.

20. Elinor Goldschmied: Creadora de la **Cesta de los Tesoros** (6 a 12 meses) y del **Juego Heurístico** (12 a 24 meses) con materiales cotidianos no plásticos.

21. Salas Snoezelen: Espacios de estimulación multisensorial inmersiva y controlada.

22. Artículo 49 de la Constitución Española: Reformado en 2024 para consagrar los derechos, autonomía e inclusión integral de las personas con discapacidad.

23. Sede central de Servicios Sociales en Utrera: **Calle Catalina de Perea, nº 32** (CSSC, EMAE y coordinación del ETF).

24. Dispositivo especializado en Utrera: Centro de Atención Infantil Temprana (CAIT) de Utrera.

25. Área prioritaria ERACIS+ en Utrera: **Barriada El Tinte** (aulas socioeducativas, talleres de crianza y estimulación temprana comunitaria).

B. Esquema Sinóptico de Repaso Rápido

```
                    ESQUEMA SINÓPTICO: TEMA 55
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1. FUNDAMENTOS Y MARCO NORMATIVO                             │
│    · Concepto: Libro Blanco (GAT, 2000), 0-6 años, niño-familia-entorno.
│    · Neurobiología: Plasticidad cerebral, sinaptogénesis, poda sináptica.
│      Periodos críticos vs. sensibles. Deprivación (Spitz, Harlow, HHA).
│    · Normativa: Ley 1/2023 de Atención Temprana de Andalucía (gratuita y
│      universal, UAIT y CAIT); LOMLOE (Educación Infantil); Art. 49 CE 2024.
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2. FUNCIONES Y NIVELES DE PREVENCIÓN                         │
│    · Primaria: Universal, parentalidad positiva, cero tóxicos embarazo.
│    · Secundaria: Detección precoz en riesgo biológico y psico-socio-ambiental
│      (Cribados: Haizea-Llevant, Denver). Foco del Educador Social.
│    · Terciaria: Tratamiento en CAIT, PII, aminorar secuelas y transición.
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3. CINCO ÁREAS DE INTERVENCIÓN                               │
│    · Motriz: Leyes Céfalo-Caudal y Próximo-Distal. Pinza fina (12 meses).
│    · Cognitiva: Piaget (Sensoriomotor 0-2 años, 6 subestadios, permanencia)
│    · Lenguaje: Prelingüística (balbuceo, atención conjunta) -> Lingüística
│      (holofrase a los 12 m, habla telegráfica a los 18-24 m).
│    · Socioafectiva: Apego seguro (Bowlby), organizadores Spitz (2-3 m y 8 m)
│    · Autonomía: Alimentación, esfínteres (24-36 m), rutinas y sueño.
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 4. ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE ESTIMULACIÓN                  │
│    · Evaluación: Escalas diagnósticas (Bayley-III, Brunet-Lézine, Battelle).
│    · PII: Basado en rutinas naturales (McWilliam), juego heurístico, cesta
│      de los tesoros (Goldschmied) y salas Snoezelen. Coaching familiar.
│    · Transición: A los 3 o 6 años con el EOE y la Escuela Infantil.
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5. ENFOQUE UTRERA                                            │
│    · CSSC Catalina de Perea 32: Detección riesgo con escala VALÓRAME (ETF).
│    · CAIT de Utrera: Coordinación técnica de derivaciones bajo Ley 1/2023.
│    · ERACIS+ Barriada El Tinte: Talleres de crianza y estimulación 0-3 años.
│    · Red de Escuelas Infantiles locales y descentralización en pedanías
│      (Guadalema de los Quintero, Trajano y Pinzón).
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

C. 7 Trampas Clásicas del Test Desarticuladas

1. La trampa sobre el rango de edad de la Atención Temprana:

Pregunta trampa: "¿A qué franja de edad se dirige legalmente la Atención Temprana según el Libro Blanco y la Ley 1/2023 de Andalucía: de 0 a 3 años o de 0 a 6 años?"

Desarticulación: **De 0 a 6 años**. Aunque el primer ciclo de educación infantil abarca de 0 a 3 años, la atención temprana cubre preceptivamente toda la etapa de la primera infancia hasta cumplir los 6 años (incluyendo el segundo ciclo de infantil).

2. La trampa entre Periodo Crítico y Periodo Sensible:

Pregunta trampa: "¿Es el aprendizaje del lenguaje un periodo crítico o un periodo sensible?"

Desarticulación: Es un **Periodo Sensible**. Un periodo crítico es biológicamente cerrado e irreversible (ej., visión binocular); el periodo sensible presenta una plasticidad mayor donde, aunque la adquisición óptima y espontánea ocurre en los primeros años, el sujeto mantiene capacidad residual de aprendizaje fuera de dicha franja.

3. La trampa sobre los niveles de prevención y el rol del Educador/a Social:

Pregunta trampa: "¿En qué nivel preventivo de la atención temprana actúa principalmente el/la Educador/a Social de Servicios Sociales ante familias en extrema pobreza?"

Desarticulación: En la **Prevención Secundaria**. La prevención secundaria abarca la detección temprana e intervención precoz sobre poblaciones en situación de **riesgo psico-socio-ambiental**. La terciaria se circunscribe al tratamiento clínico del trastorno ya diagnosticado en el CAIT.

4. La trampa sobre las Leyes del Desarrollo Psicomotor:

Pregunta trampa: "¿Qué ley psicomotriz explica que el menor aprenda a controlar los hombros y brazos antes de lograr la pinza fina con los dedos?"

Desarticulación: La **Ley Próximo-Distal** (el desarrollo avanza desde el eje central del cuerpo hacia la periferia). La Ley Céfalo-Caudal explica el control desde la cabeza hacia los pies.

5. La trampa sobre la autoría de la Cesta de los Tesoros:

Pregunta trampa: "¿Quién diseñó la técnica de estimulación sensorial de la Cesta de los Tesoros: María Montessori o Elinor Goldschmied?"

> *Desarticulación:* **Elinor Goldschmied** (pedagoga británica que conceptualizó la Cesta de los Tesoros para bebés de 6 a 12 meses y el Juego Heurístico de 12 a 24 meses). Atribuirlo a Montessori es un error clásico recurrente en exámenes.

6. La trampa sobre la entrada en vigor del marco normativo en Andalucía:

> *Pregunta trampa:* "¿Cuál es la norma legal con rango de ley que regula actualmente la Atención Temprana en Andalucía?"

> *Desarticulación:* La **Ley 1/2023, de 16 de febrero, de Atención Temprana de Andalucía**. El antiguo Decreto 85/2016 quedó derogado por esta ley, que elevó la atención temprana a derecho subjetivo universal, público y gratuito, creando las Unidades de Atención Infantil Temprana (UAIT).

7. La trampa sobre el modelo de intervención: clínico vs. rutinas naturales:

> *Pregunta trampa:* "¿Qué caracteriza al modelo de Atención Temprana promovido internacionalmente por Robin McWilliam?"

> *Desarticulación:* Es un **Modelo Basado en Rutinas Familiares y Entornos Naturales**, donde los objetivos se integran en la vida cotidiana del hogar (baño, comidas, juego) y los padres son capacitados como mediadores clave, en contraposición al modelo clínico tradicional de mesa y consultorio.

D. Supuesto Práctico Modal en el Ayuntamiento de Utrera

Supuesto: Intervención Socioeducativa y Estimulación Temprana ante Lactante de 14 Meses con Retraso Psicomotor y del Lenguaje por Riesgo Psico-Socio-Ambiental en la Barriada El Tinte

1. Identificación y Detección del Caso: En el marco de las visitas de prospección comunitaria de la estrategia **ERACIS+ en la Barriada El Tinte**, el/la Educador/a Social del **Centro de Servicios Sociales Comunitarios (calle Catalina de Perea, 32)** detecta la situación del lactante *K.S.M.*, de 14 meses de edad.

- **Factores de Riesgo:** Núcleo monoparental; madre de 19 años en situación de aislamiento y exclusión social severa; antecedentes de consumo intermitente de tóxicos; vivienda precaria en régimen de ocupación.
- **Signos de Alerta Observados:** El menor no camina ni se pone de pie con apoyo (hipotonía generalizada en extremidades inferiores); no emite balbuceo comunicativo ni primeras palabras (únicamente llanto monótono); no realiza contacto ocular continuado ni responde a su nombre; permanece la mayor parte del día tumbado en un parque de juegos viendo vídeos en un teléfono móvil ("chupete digital").

2. Fase de Valoración Inicial y Aplicación del Instrumento VALÓRAME:

- El/La Educador/a Social realiza una entrevista sociofamiliar en el domicilio y aplica la escala **Haizea-Llevant**, constatando un desfase madurativo global superior a 6 meses en motricidad gruesa, fina y lenguaje expresivo.
- Se cumplimenta la escala **VALÓRAME** (**Decreto 100/2022**), catalogando la situación como de **desprotección infantil moderada por negligencia en la estimulación básica y cuidados higiénicos.**

3. Circuito de Derivación Intersectorial (Ley 1/2023 de Andalucía):

- Coordinación inmediata con el Pediatra del **Centro de Salud Utrera-Sur**, quien emite la derivación formal a la **Unidad de Atención Infantil Temprana (UAIT)** del Servicio Andaluz de Salud.
- Tras la valoración diagnóstica de la UAIT, se asigna plaza prioritaria y gratuita en el **Centro de Atención Infantil Temprana (CAIT) de Utrera**, reconociéndose la necesidad de estimulación global y fisioterapia pediátrica (PII de 2 sesiones semanales).

4. Plan de Intervención Socioeducativa en el Hogar y Comunidad: El Educador/a Social diseña un plan complementario en el medio natural con la madre:

1. Erradicación del Tóxico Digital: Retirada total de teléfonos móviles y pantallas al lactante. Explicación pedagógica del daño neuronal demostrado en menores de 0 a 3 años.

> **2. Capacitación en el Modelo de Rutinas Naturales (Robin McWilliam):**

- *Rutina de la Alimentación*: La madre se sienta enfrente del menor, mirándolo a los ojos, hablándole con entonación melódica y permitiéndole explorar texturas con las manos y la cuchara (pinza digital).
- *Rutina del Suelo (Motricidad)*: Se elimina el confinamiento en el parque infantil; se instala una colchoneta de goma en el suelo donde el Educador modela juegos de arrastre, estimulación del gateo con juguetes atractivos a corta distancia y tracción a la bipedestación.

3. **Cesta de los Tesoros de Elinor Goldschmied**: El Educador Social elabora junto a la madre una cesta con materiales cotidianos naturales (cuchara de madera, piñas, esponja natural, anillas de metal) para enriquecer la exploración sensoriomotora en casa.

4. **Inserción en el Aula de Crianza de ERACIS+ en el Centro Cívico de El Tinte**: Asistencia semanal a sesiones de juego compartido con otras madres del barrio, normalizando el balbuceo y la interacción con iguales.

5. Escolarización Temprana: Tramitación de plaza de urgencia social en la **Escuela Infantil Municipal (0-3 años)** de Utrera para garantizar un entorno estructurado de socialización y nutrición balanceada.

5. Seguimiento y Resultados:

- A los 4 meses de intervención coordinada (CAIT de Utrera + Educador Social en domicilio + Escuela Infantil), *K.S.M.* adquiere la marcha autónoma estable, emite sus primeras 8 palabras funcionales con intencionalidad comunicativa (holofrases) y muestra una relación de apego seguro con su madre, cerrándose el expediente en fase de riesgo moderado y consolidando pautas de parentalidad positiva.

E. Fuentes Oficiales y Bibliografía Consolidada

Normativa Internacional, Estatal y Autonómica

- **Constitución Española de 1978** (*BOE nº 311, de 29 de diciembre de 1978*): Artículos 27, 39 y 49 (reforma constitucional de 15 de febrero de 2024 sobre discapacidad).
- **Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño**, adoptada por la Asamblea General el 20 de noviembre de 1989.
- **Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE)** (*BOE nº 106, de 4 de mayo de 2006*), modificada por la **Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre (LOMLOE)** (*BOE nº 340, de 30 de diciembre de 2020*): Artículos 12 a 15 (Educación Infantil y NEAE).
- **Ley 1/2023, de 16 de febrero, de Atención Temprana de Andalucía** (*BOJA nº 36, de 22 de febrero de 2023; BOE nº 61, de 13 de marzo de 2023*).
- **Ley 4/2021, de 27 de julio, de Infancia y Adolescencia de Andalucía** (*BOJA nº 149, de 4 de agosto de 2021*).
- **Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía** (*BOJA nº 249, de 29 de diciembre de 2016*).
- **Decreto 100/2022, de 7 de junio**, por el que se regula el papel de los Equipos de Tratamiento Familiar en Andalucía (*BOJA nº 111, de 13 de junio de 2022*).

Bibliografía Doctrinal y Científica de Referencia

- **Ainsworth, M. D. S. (1978).** *Patterns of Attachment: A Psychological Study of the Strange Situation*. Lawrence Erlbaum Associates.
- **Ayres, A. J. (1979).** *Sensory Integration and the Child*. Western Psychological Services.
- **Barudy, J., & Dantagnan, M. (2005).** *Los buenos tratos a la infancia: Parentalidad, apego y resiliencia*. Gedisa.
- **Bowlby, J. (1969).** *Attachment and Loss: Vol. 1. Attachment*. Basic Books.
- **Bruner, J. (1983).** *Child's Talk: Learning to Use Language*. W. W. Norton & Company. (Trad. esp.: *El habla del niño*. Paidós, 1986).
- **Goldschmied, E., & Jackson, S. (2000).** *La educación infantil de 0 a 3 años*. Morata.
- **Grupo de Atención Temprana (GAT). (2000).** *Libro Blanco de la Atención Temprana*. Real Patronato sobre Discapacidad / Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
- **Harlow, H. F. (1958).** *The nature of love*. American Psychologist, 13(12), 673-685.
- **Hubel, D. H., & Wiesel, T. N. (1970).** *The period of susceptibility to the physiological effects of unilateral eye closure in kittens*. The Journal of Physiology, 206(2), 419-436.
- **Kandel, E. R., Schwartz, J. H., & Jessell, T. M. (2012).** *Principles of Neural Science* (5ª ed.). McGraw-Hill.
- **Lenneberg, E. H. (1967).** *Biological Foundations of Language*. John Wiley & Sons.
- **McWilliam, R. A. (2010).** *Routines-Based Early Intervention: Supporting Young Children and Their Families*. Paul H. Brookes Publishing.
- **Piaget, J. (1936).** *La naissance de l'intelligence chez l'enfant*. Delachaux et Niestlé. (Trad. esp.: *El nacimiento de la inteligencia en el niño*. Aguilar, 1972).

- **Shonkoff, J. P., et al. (2012)**. *The lifelong effects of early childhood adversity and toxic stress*. Pediatrics, 129(1), e232-e246.
- **Spitz, R. A. (1945)**. *Hospitalism: An inquiry into the genesis of psychiatric conditions in early childhood*. The Psychoanalytic Study of the Child, 1(1), 53-74.
- **Vygotsky, L. S. (1934)**. *Pensamiento y lenguaje*. Obras escogidas, Tomo II. Visor.